
MONOGRAFIA DEL PRODUCTO

MIGRÉTIL

Tratamiento de las crisis de jaqueca

1. Denominación del medicamento

MIGRÉTIL

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Paracetamol 400 mg; cafeína 100 mg; tartrato de ergotamina 1 mg; alcaloides de belladona 0,1 mg; por comprimido.

3. Forma farmacéutica

Comprimidos no recubiertos.

4. Datos clínicos

4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de las crisis de jaqueca. No está indicado como tratamiento preventivo.

4.2. Posología y forma de administración

Salvo otra prescripción indicada por el médico, MIGRÉTIL se tomará de la siguiente manera:

Adultos: Dos comprimidos a la vez, durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si resulta necesario, administrar 1 comprimido después de media hora, y otro comprimido tras otra media hora si los síntomas persisten.

Adolescentes: Un comprimido durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si resulta necesario, administrar 1 comprimido después de media hora.

No está indicado para niños menores de 12 años.

Los comprimidos se tomarán lo más precozmente posible, tras los primeros síntomas de crisis de jaqueca.

No ingerir más de 6 comprimidos al día o más de 10 ó 12 comprimidos por semana.

Los comprimidos se tomarán enteros con un poco de agua.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a algún de los excipientes. Embarazo y lactancia; alcoholismo activo; insuficiencia hepática significativa. Angioplastia o cirugía vascular recientes o previstas; enfermedad vascular periférica oclusiva; hipertensión no controlada; enfermedad coronaria.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

El riesgo de complicaciones aumenta en caso de infecciones graves, insuficiencia renal significativa y en los pacientes geriátricos.

En los enfermos ansiosos la cafeína puede aumentar los síntomas. Debe evitarse el uso concomitante de bebidas conteniendo cafeína.

Los enfermos con hipertrofia prostática, retención urinaria, enfermedad gastrointestinal oclusiva o glaucoma pueden ser objeto de acciones nocivas resultantes de los alcaloides de belladona, aunque las dosis utilizadas en MIGRÉTIL sean bajas.

4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

Las xantinas pueden incrementar los efectos de los estimulantes beta-adrenérgicos. La utilización concomitante de estimulantes del sistema nervioso central puede provocar efectos adicionales indeseables como, nerviosismo, irritabilidad, insomnio,

convulsiones y arritmias. La utilización concomitante de inhibidores de la monoaminoxidasa puede causar taquicardia, arritmias o hipertensión. La cafeína antagoniza los efectos de la adenosina y de los bloqueadores beta.

La administración concomitante de vasoconstrictores sistémicos (cocaína, epinefrina, metaraminol, metoxamina, norepinefrina, fenilefrina, soluciones anestésicas locales con vasoconstrictores, amins simpaticomiméticas), así como el tabaquismo, potencian los efectos vasopresores de los alcaloides del cornezuelo del centeno. Esta clase de fármacos antagoniza los efectos vasodilatadores de la nitroglicerina. Hay que tomar precauciones especiales con la utilización simultánea de propranolol y dosis elevadas de alcaloides del cornezuelo del centeno, considerando el riesgo de vasoconstricción periférica grave.

El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad inducida por el paracetamol. La cafeína potencia los efectos de las otras xantinas, pudiendo disminuir la eliminación de éstas. La eritromicina y la troleandomicina disminuyen el metabolismo de los alcaloides del cornezuelo del centeno, aumentando el riesgo de vasospasmo

4.6. Embarazo y lactancia

No utilizar durante el embarazo y la lactancia.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No interfiere cuando se utilizan las dosis recomendadas.

4.8. Reacciones adversas

A las dosis recomendadas MIGRÉTIL es habitualmente bien tolerado. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad cutánea, signos de irritación gástrica, diarrea, insomnio, nerviosismo, mialgias, parestesias y disminución de fuerza en los miembros inferiores. Los efectos de vasoconstricción suelen sentirse en cualquier vaso, existiendo una gran variabilidad individual. Estos efectos suelen manifestarse por extremidades frías, adormecidas y dolorosas, con o sin parestesias.

4.9. Sobredosis

Casos de sobredosis o intoxicación aguda pueden aparecer, ocasionalmente, en enfermos que toman dosis más altas que las recomendadas o en individuos con intentos suicidas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, excitabilidad, agitación, escotomas, tinnitus, temblores, taquicardia, arritmias, aumento de la diuresis, mialgias, parestesias, disminución de la fuerza de los miembros inferiores y extremidades frías, adormecidas o dolorosas. En casos más graves puede observarse angor, ceguera monocular transitoria, papilitis bilateral, colitis isquémica, vasoconstricción de la arteria renal, gangrena en las extremidades, necrosis hepática, alteración de la función mental, delirium, disnea, hipo o hipertensión, pulso débil, espasmos musculares, convulsiones, shock y muerte.

El tratamiento de las situaciones de sobredosis aguda consiste en medidas generales de soporte y tratamiento sintomático. La inducción del vómito y lavado gástrico son importantes si la ingesta del fármaco hubiera sido efectuada hace menos de 4 horas, así como la administración de carbón activado. La utilización de demulcentes puede reducir la irritación gástrica. Habrá que prevenir el calentamiento de las extremidades y, eventualmente, la administración de vasodilatadores y heparina. En caso de necrosis

hepática secundaria al paracetamol, hay que administrar acetilcisteína en las primeras 24 a 36 horas, siendo la eficacia mayor cuanto más precoz sea la actuación.

5. Propiedades farmacológicas

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Medicamentos usados en la jaqueca.

Código ATC: N02CA - Preparaciones contra la jaqueca, alcaloides, ergotamina

Paracetamol: Tiene efectos analgésicos y antipiréticos debidos a un mecanismo no completamente esclarecido, el cuál puede ser semejante al de los salicilados. En lo que se refiere a la analgesia, el paracetamol puede actuar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y, en menor grado, bloqueando la génesis del impulso del dolor, periféricamente. La acción periférica también puede ser atribuible a la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas ó a la inhibición de la síntesis y/o acción de otras sustancias que sensibilizan los receptores del dolor a la estimulación mecánica o química.

Cafeína: Es una metilxantina que aparece naturalmente en el té y café, siendo todavía preparada sintéticamente para usos comerciales. Potencia la acción de los alcaloides del cornezuelo del centeno en el tratamiento de la jaqueca, aumentando la absorción gastrointestinal de la ergotamina.

La cafeína puede también contribuir a la vasoconstricción cerebral y consecuente reducción del flujo sanguíneo y de la tensión local del oxígeno. Es utilizada en asociación con analgésicos como el paracetamol en la terapéutica de la cefalea. La cafeína no ejerce ningún efecto analgésico intrínseco; si bien las asociaciones conteniendo cafeína han sido descritas como portadoras de un efecto analgésico más rápido y más potente, lo que permite reducir las dosis de la sustancia analgésica.

Tartrato de ergotamina: Es un alcaloide del cornezuelo del centeno que sigue siendo un agente importante en el alivio sintomático de la cefalalgia de la jaqueca, particularmente en los enfermos en que los fármacos de tipo aspirina sólo provocan alivio incompleto. Posee efectos farmacológicos complejos. A dosis terapéuticas causa vasoconstricción periférica estimulando los receptores alfaadrenérgicos y deprimiendo los centros vasomotores.

Parece que el mecanismo por el cuál la ergotamina actúa sobre las cefaleas de etiología vascular, se debe a los efectos directos de la vasoconstricción sobre las arterias carótidas externas, provocando el descenso de la amplitud del pulso. El efecto de la ergotamina sobre las catecolaminas y la serotonina puede contribuir a la eficacia terapéutica.

Alcaloides de belladona: Son fármacos anticolinérgicos. Las dosis utilizadas en el MIGRÉTIL no son suficientes para que este efecto se observe.

La estasis gástrica, las náuseas y los vómitos son síntomas y signos presentes en la mayoría de los casos de jaqueca. Los alcaloides de belladona ejercen un efecto anti-emético beneficioso, que contribuye al alivio sintomático de la crisis.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

Paracetamol: Es rápida y casi completamente absorbido a partir del tracto gastrointestinal. La concentración máxima es alcanzada después de 10-60 minutos. Tras una dosis de 500 mg, la concentración máxima es de 2,1 mcg/mL. Es rápida y uniformemente distribuido a casi todos los tejidos, incluso a la leche materna. Atraviesa la placenta. Aproximadamente el 25% de la concentración plasmática del paracetamol se une a las proteínas plasmáticas. La semivida de eliminación plasmática es de 1-3 horas. Es metabolizado por las enzimas microsomales hepáticas. Aproximadamente uno 80-85% de la dosis administrada sufre conjugación, principalmente con el ácido glucorónico y, en menor grado, con el ácido sulfúrico. Una pequeña cantidad es conjugada con la cisteína. El paracetamol es excretado por vía urinaria, bajo la forma conjugada o libre. En 24 horas tras la administración de una dosis única, aproximadamente el 85% es excretado por esta vía.

Cafeína: Es absorbida a partir del tracto gastrointestinal, siendo la absorción oral superior a la absorción por vía intramuscular. Tras la administración oral de 100 mg de cafeína, la concentración máxima es de 1,5-1,8 mcg/mL, que se alcanza tras 50-75 minutos. La distribución es muy amplia y rápida, atravesando la barrera hemato-encefálica y la placenta y pasando a la leche materna. Aproximadamente se un 17% se une a las proteínas plasmáticas. La cafeína es parcialmente desmetilada, oxidada y acetilada en el hígado, siendo los metabolitos excretados en la orina. Sólo un 1% es excretado inalterado. La semivida de eliminación plasmática es de 3-4 horas en el adulto, pudiendo ser superior a 100 horas en los recién-nacidos.

Tartrato de ergotamina: Tras la administración oral, la absorción de la ergotamina es variable, siendo disminuida por la estasis gástrica que habitualmente acompaña las jaquecas. La absorción es mayor en la primera hora tras la administración, particularmente si es administrada concomitantemente con la cafeína.

El efecto de primer paso contribuye a la reducción de la biodisponibilidad. Atraviesa la barrera hemato-encefálica y se detecta en la leche materna. Aproximadamente el 95% circula ligado a las proteínas plasmáticas. El tiempo para alcanzar la concentración máxima es de 2 horas, reduciéndose este valor a la mitad si se administra concomitantemente la cafeína. La acción depende de la precocidad de la ingesta de la ergotamina en relación al inicio de la jaqueca. Tras la administración oral de ergotamina a individuos con función renal y hepática conservada, las concentraciones plasmáticas declinan de una manera bifásica, con una semivida media inicial de 2,7 horas y final de 21 horas. La ergotamina y especialmente el componente peptídico de la molécula, es casi totalmente metabolizado, probablemente a nivel hepático. Algunos de los metabolitos podrán ser farmacológicamente activos. La principal vía de excreción es la fecal (biliar), siendo la vía urinaria responsable de sólo un 4%.

Alcaloides de belladona: Son bien absorbidos por el tracto gastrointestinal. Se conoce poco sobre la distribución, metabolismo y excreción. Probablemente son hidrolizados en tropina y ácido trópico, siendo sus derivados excretados en la orina y, en menor grado, en las heces.

6. Datos farmacéuticos

6.1. Lista de excipientes

Povidona K30, ácido tartárico, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, Eudragit, metil-hidroxipropilcelulosa, dietilftalato y Opaspray K-1-7000.

6.2. Incompatibilidades

El sulfato de atropina es incompatible con las bases, ácido tánico y sales de mercurio.

El bromhidrato de escopolamina es incompatible con las bases, sales de plata y ácido tánico.

6.3. Periodo de validez

Dos años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura entre 15 - 30°C.

6.5. Naturaleza y contenido del recipiente

Envase de cartón con 20 comprimidos y un prospecto.

6.6. Precauciones especiales de eliminación

Ninguna especial. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales.

7. Titular de la Autorización de Comercialización

BIAL – Portela & C^a SA

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

8. Número de Autorización de Comercialización

4131-APG-16686

9. Fecha de la primera autorización/renovación de la autorización

Fecha de la primera autorización: 09/01/1996

Fecha de la última renovación de la autorización: 03/10/2007

10. Fecha de la revisión del texto

06/2009

Referencias Bibliográficas

1. Acetaminophen. In American Hospital Formulary Service 2012, American Society of Health-System Pharmacists, p. 2227-2235.
2. Acetaminophen. In USP - Drug Information for the Health Care Professional 2007, 27th ed. Thomson Micromedex, p. 15-18
3. Paracetamol. In Martindale The Complete Drug Reference, 35th ed., The Pharmaceutical Press, 2007, p 92-4
4. Caffeine. In American Hospital Formulary Service 2012, American Society of Health-System Pharmacists, p. 2588-2592
5. Vascular headache suppressants, ergot derivative-containing. In: USP - Drug Information for the Health Care Professional 2002, 22ed., p. 2899-2910
6. Ergotamine Tartrate. In American Hospital Formulary Service 2012, American Society of Health-System Pharmacists p. 1380-1382
7. Belladonna. In American Hospital Formulary Service 2007, American Society of Health-System Pharmacists, p. 1272-1273
8. Caffeine. In USP - Drug Information for the Health Care Professional 2007, 27th ed., Thomson Micromedex, p. 663-668
9. Caffeine. In Martindale - The Complete Drug Reference, 35th ed.,The Pharmaceutical Press, 2007, p. 1003-1005
10. Ergotamine tartrate. In Martindale - The Complete Drug Reference, 35th ed.,Pharmaceutical Press, 2007, p.563-565
11. Antimigraine agents. In Martindale - The Extra Pharmacopoeia 1999, 32 ed., p. 443-44
12. Peroutka S. J. Drugs effective in the therapy of migraine. In Goodman's & Gilman's, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed. (1996), p. 487-502
13. Raskin NH. Headache. In Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed..Kasper DL et al Eds.New York :McGraw-Hill 2005, p. 85-94